SUPSI

Società e economia

Dalla “malattia dei costi” alla crisi del personale e del lavoro di cura

Nicolas Pons-Vignon

Le cure di lunga durata, un settore in crisi

- In Svizzera, un settore "sull'orlo del collasso" (*NZZ* 16/8/2023) – la pandemia di COVID ha *rivelato* (non causato) la crisi (Bally et al., 2023).
- Un'osservazione condivisa da molti Paesi: l'OCSE (2023) esorta le autorità pubbliche a "fare di più che applaudire".
- Cure di L-D in Svizzera: un settore in rapida crescita
  - la spesa triplicherà entro il 2045 (Consiglio federale, 2020)
  - la domanda di mano d'opera aumenterà di quasi il 40% entro il 2033 (OCSE, 2023).
- Eppure non si riesce a reclutare e trattenere i dipendenti ➔ **crisi del personale**
- Il paradosso del **«sticky wage»**
- Scandali che rivelano maltrattamenti sistemici, per esempio nel settore privato: Orpéa, libro di V. Castanet *Les fossoyeurs* (i becchini), eppure...

Oro grigio: un settore promettente per gli investitori

- Indagine sulla privatizzazione delle cure di LD in Europa
  - https://www.investigate-europe.eu/en/posts/elder-care-for-profit
- L'attrattiva del settore per imprese specializzate / investitori speculativi (*private equity*) / aziende di altri settori (come Sodexo) che gestiscono personale femminile a bassa retribuzione, può essere spiegata dai seguenti fattori
  - Domanda garantita (invecchiamento)
  - finanziamento statale di una parte significativa dei costi (220 miliardi di euro di fondi pubblici versati ogni anno a tutti gli operatori dell'OCSE).
- Strategie per aumentare i profitti: speculazione immobiliare (separazione tra gestione e proprietà immobiliare) e '"ottimizzazione" dei costi, in particolare di quelli del personale.
- Con lo sviluppo del **New Public Management**, e la messa in concorrenza di tutte le case per anziani, i stessi metodi di «ottimizzazione» vengono usati nelle case pubbliche e semi-pubbliche

Capire la crisi delle cure di LD

- La "malattia di Baumol" (1993) o **malattia dei costi** si riferisce al fatto che i servizi alla persona, come le cure o l'educazione, soffrono di una bassa crescita della produttività rispetto ad altre attività, come l'industria manifatturiera, dove i rapidi aumenti di produttività portano a costi unitari del lavoro più bassi.

  Perché?

  - i servizi alla persona "comportano processi produttivi incompatibili con la standardizzazione" e
  - "la qualità è inevitabilmente correlata alla quantità di lavoro umano dedicato alla loro produzione".
- Problema: La società è disposta a spendere di più per coprire i costi di questi servizi?
- Baumol: è possibile economicamente, ma politicamente…
  - Il principio del pareggio di bilancio è una decisione politica, che comporta conseguenze molto importante per la società
- L'ironia del NPM: spinge alla *standardizzazione* del lavoro di servizio

Rispondere alla crisi delle cure di LD

- Nella maggior parte dei Paesi, compresa la Svizzera, la principale risposta alla carenza di manodopera nell'assistenza a lungo termine è l'immigrazione.
  - Le condizioni di lavoro sono pessime, soprattutto per le cure a domicilio (tragedia del Covid per le badanti)
  - Questo fenomeno aumenta *l'imperialismo della cura*
- Per tanti, la risposta potrebbe essere… tecnologica, come in Giappone?



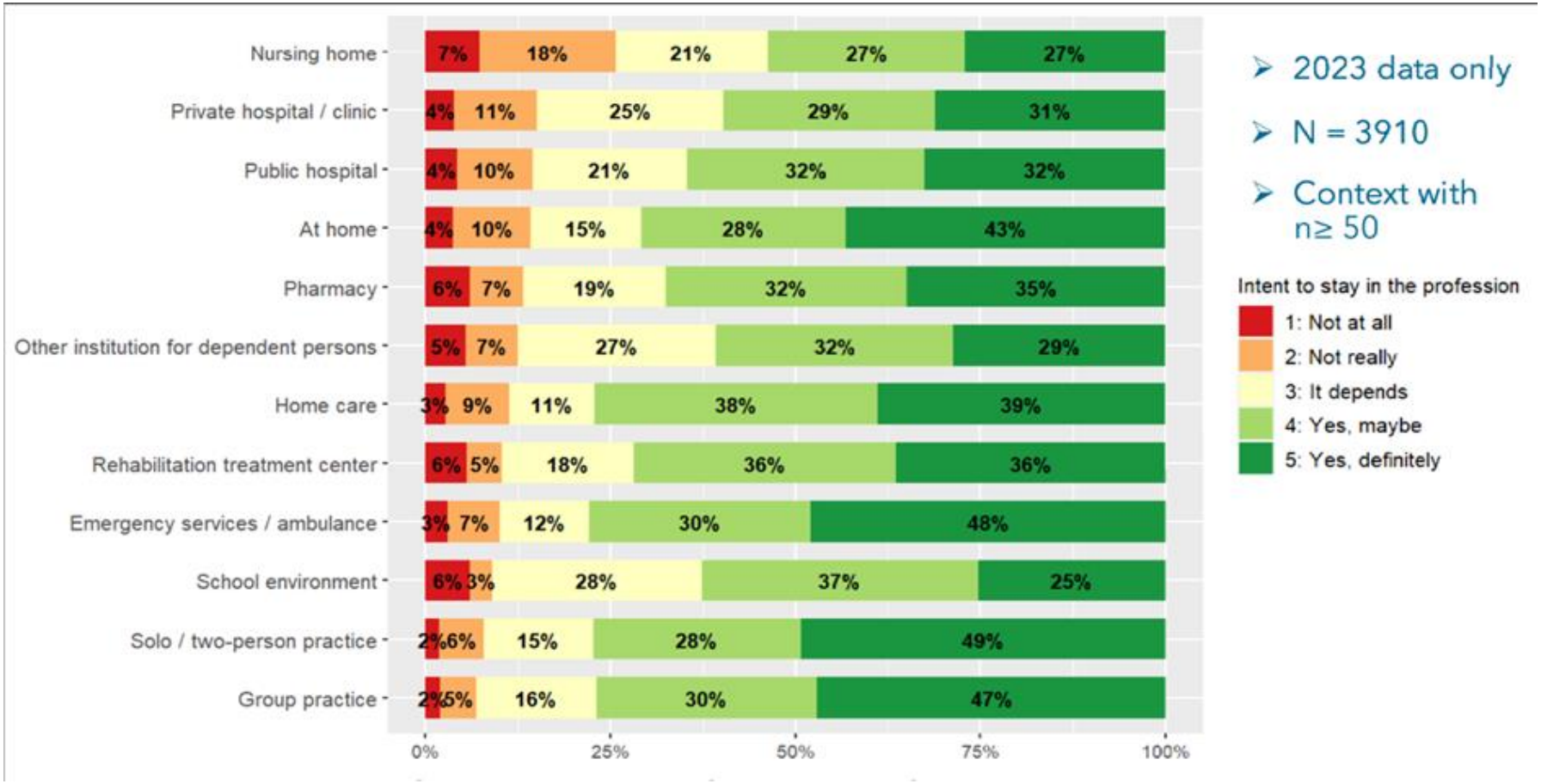
Inside Japan's long experiment in automating elder care. https://www.technologyreview.com/2023/01/09/1065135/japan-automating-eldercare-robots/

- In breve, le macchine non sono riuscite a risparmiare lavoro. I robot stessi richiedevano assistenza: dovevano essere spostati, sottoposti a manutenzione, puliti, avviati, azionati, spiegati ripetutamente ai residenti, monitorati costantemente durante l'uso e riposti in seguito. In effetti, un numero crescente di studi dimostra che i robot tendono a creare più lavoro per gli assistenti. Ma l'aspetto interessante è stato il tipo di lavoro creato.
- Mentre in precedenza gli assistenti si inventavano le proprie attività ricreative, ora dovevano semplicemente copiare Pepper. Invece di conversare e interagire con i residenti, ora potevano dare loro Paro per giocare e monitorare l'interazione a distanza. E laddove gli operatori che dovevano sollevare un residente avevano sfruttato l'occasione per fare due chiacchiere e costruire il loro rapporto, quelli che utilizzavano la macchina Hug dovevano abbreviare l'interazione in modo da avere il tempo di riportare il robot al suo posto.
- i compiti sociali e di comunicazione esistenti tendevano a essere sostituiti da nuovi compiti che comportavano più interazione con i robot che con i residenti. Invece di far risparmiare tempo al personale, che avrebbe potuto dedicarsi maggiormente al lavoro umano di assistenza sociale ed emotiva, i robot hanno di fatto ridotto la possibilità di svolgere tale lavoro.

Cosa pensano i dipendenti di questi cambiamenti?

- Bella domanda! Le ricerche sulle opinioni dei dipendenti sono molto scarse. Le loro opinioni sono tipicamente sollecitate tramite questionari "chiusi", che confermano la loro crescente frustrazione.
- Si esprime con assenze, lavoro a tempo parziale e dimissioni: il tasso di turnover in Svizzera è passato dal 20,8% nel 2013 al 22,4% nel 2019 (Merçay et al, 2021), poi 24% nel 2021 e **28% nel 2022.**
  - Questo fenomeno riguarda soprattutto i nuovi assunti; una buona parte si dimette entro i primi 2 anni.
- Che cos'è la qualità delle cure? Sei indicatori elaborati nel 2016 (nonostante una legge del 1994) da un gruppo di 4 "stakeholder": Curaviva, l'UFSP, l'Ufficio federale di statistica e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità.
  - Non manca qualche stakeholder...?
- Gli indicatori misurano la qualità con un focus tecnico-medico – il tempo necessario per curare le relazioni non è riconosciuto ➔ *rationing of care*

Intent to stay in the profession – SCOHPICA, 2024



Cosa manca nella ricerca medicale sulla qualità delle cure?

- The factors shaping healthcare quality have been extensively studied, yet a crucial element remains overlooked: the role of unions. (…) Epidemiological research, including on the social determinants of health, has also failed to recognise the role of unions even when economics researchers have provided extensive analysis of the relationship between labour unions and various socio-economic indicators (Leigh and Chakalov 2021). The omission is significant in light of clear evidence showing how unions are instrumental in improving staffing ratios among other improvements in working conditions that, in turn, contribute to increasing the quality of care.
  - https://globallabourcolumn.org/2024/11/19/the-overlooked-role-of-unions-in-healthcare-quality-research/

- **La ricerca e la politica non prendono in considerazione la prospettiva del personale**